PROTOCOLLO 93

ATM nelle artriti infiammatorie

Supportare funzione e dolore in collaborazione con il reumatologo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artrite infiammatoria	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Artrite reumatoide, psoriasica o idiopatica giovanile
- ✓ Rigidità mattutina articolare
- ✓ Dolore bilaterale fluttuante

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela
- ! Instabilità cervicale nelle artriti infiammatorie

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Collaborazione
Verifica la terapia e la fase della malattia con il reumatologo.



Fase attiva
Gestione del dolore e mobilità dolce.



Fase quiescente
Esercizio per mobilità e funzione.



Monitoraggio
Cambiamenti di occlusione e apertura.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Fase attiva	solo tecniche delicate
Esercizio	quotidiano e leggero
Comunicazione	con il reumatologo

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Adatta il trattamento alla fase della malattia
- ✓ Monitora l'occlusione
- ✓ Coinvolgi il medico

Errori da evitare

- ! Mobilizzazioni intense nella fase attiva
- ! Ignorare cambi di occlusione
- ! Trattare senza diagnosi medica

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Mobilità leggera	Aperture lente al mattino dopo il calore	10 ripetizioni ogni mattina

! **Nota clinica.** Nelle artriti infiammatorie il cervicale alto può essere instabile: evita tecniche cervicali ad alta velocità.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.